

HERIDAS FACIALES

Raúl Antúñez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno

INTRODUCCIÓN

Una herida se define como solución de continuidad en la piel o en las mucosas. En general, las heridas faciales no suponen una urgencia vital pero, requieren un tratamiento adecuado con la mayor brevedad y con técnica cuidadosa debido a la importancia estética que implican.

El manejo inicial de todo paciente con heridas faciales no difiere del que se aplica a cualquier paciente politraumatizado. Una vez estabilizado el paciente, se procederá al tratamiento de las heridas.

DIAGNÓSTICO

Podemos clasificar las heridas en función de:

- **Dirección:** longitudinales, transversales, oblicuas.
- **Forma:** Lineales, curvas, anguladas, estrelladas, puntiformes, crateriformes, pediculadas (en cuero cabelludo reciben la denominación scalp), con o sin pérdida de sustancia.
- **Mecanismo lesional:** contusas (producidas por objetos romos), incisas (por objetos afilados), punzantes, por desgarro, por arma de fuego.
- **Profundidad:** abrasiones, superficiales, profundas, penetrantes.

TRATAMIENTO

Tratamiento básico de las heridas en urgencias

Como normal general realizaremos infiltración con anestésicos locales en la propia herida si bien, en caso de heridas extensas, el uso de un bloqueo locorregional nos proporcionará mayor comodidad y una menor distorsión del campo a tratar.

Además, el uso de un vasoconstrictor añadido al anestésico facilitará la visualización del lecho de la herida al disminuir el sangrado.

Posteriormente, lavaremos con suero fisiológico la herida y retiraremos posibles cuerpos extraños. En caso de hemorragia, realizaremos hemostasia mediante ligadura del vaso responsable, cauterización o simplemente mediante compresión. Aplicaremos un desinfectante como la povidona yodada o la clorhexidina.

Debido a la rica vascularización facial, el tiempo hasta la reparación de la herida puede ser mayor a 6 horas.

En general, las **abrasiones superficiales** pueden tratarse de modo similar a una, quemadura superficial, es decir, **limpieza mediante lavados vigorosos con suero y una cura húmeda** que favorezca la reepitelización espontánea. Recomendaremos mantener la cicatriz con adecuada hidratación y protección solar por un período no menor a seis meses.

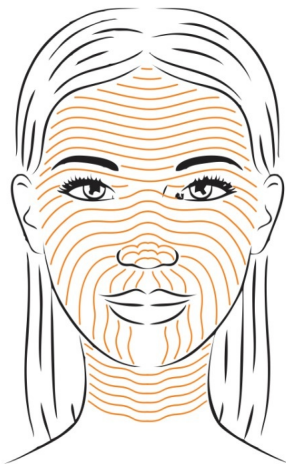
Ante una herida contusa, de bordes irregulares, desvitalizados o muy contaminados debemos asear bien la herida y eliminar los tejidos no viables.

Las **heridas faciales simples**, sin gran distancia entre bordes (<10mm), sin pérdida de sustancia,

que comprometen sólo a la piel y que no muestren contaminación importante podrán ser suturadas en un plano, con **puntos simples de material no absorbible** (Nylon 4/0 – 6/0).

Siempre deberemos tener en cuenta la dirección del trazo de la herida y las **líneas de Langer**.

En caso de tratarse de una **herida más profunda**, será necesario **suturar por planos** para evitar dehiscencias; utilizaremos material de tipo absorbible 3/0 o 4/0.



Consideraciones especiales en función de localización anatómica

- **Cuero cabelludo.**
 - No es necesario rasurar la zona afectada.
 - Sutura en un solo plano. Hilo o grapas.
 - Es preferible dejar las heridas al aire libre.
- **Frente**
 - Si la herida compromete a la ceja, nunca rasurar y suturar inicialmente para no perder la referencia anatómica y conseguir un resultado estético.
- **Párpados**
 - El párpado es una estructura muy vascularizada, que suele cicatrizar muy bien, por lo que pueden retirarse los puntos en 3-4 días.
 - Valoración por parte de Oftalmología.
- **Cavidad bucal y labios**
 - No es necesario realizarlo en condiciones de esterilidad.
 - Comenzar por el bermellón, consiguiendo una perfecta alineación de la unión mucocutánea.
 - Si la herida comprometiera todas las estructuras del labio, comenzar suturando, con material absorbible, la unión fibroadiposa posterior; posteriormente el plano muscular y, a continuación, la lámina fibroadiposa anterior, que acerca la piel. Por último, se suturan las superficies cutánea y mucosa, con sutura no absorbible y absorbible, respectivamente.
- **Pabellón auricular.**
 - El principal objetivo al suturar una herida en la oreja es evitar que el cartílago quede descubierto por el riesgo de condritis erosiva y posterior necrosis
 - Necesidad de cobertura antibiótica.
- **Pirámide nasal**
 - Las heridas que afectan a la pirámide nasal deben ser suturadas antes de la reducción de la fractura de huesos propios en caso de que exista.
 - Los dos tercios superiores de la nariz pueden suturarse por planos.

- Enfocar nuestros esfuerzos a cubrir cartílago expuesto.

PUNTOS CLAVE

- Siempre esforzarnos en obtener un resultado estético cuando se trata de la región facial.
- La sutura de planos profundos y mucosas se realizará con material absorbible.
- La sutura de planos superficiales se realizará con material no absorbible.
- Valorar siempre cobertura antibiótica y necesidad de profilaxis antitetánica.

BIBLIOGRAFÍA

- Trott AT. Heridas y Cortes. Tratamiento y sutura de urgencia. 3ª ed. Madrid: Elsevier; 2007.
- Rodríguez Ruiz JA. Urgencias en Cirugía oral y Maxilofacial. Cádiz: Universidad, Servicio de Publicaciones; Madrid: Stratec Medical; 2003.
- Bruno Dagnino U, Rodrigo Ramírez A. Manejo de heridas faciales. Cuad Cir. 2006;20:100-107.